

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO MAR 17 26 AM 11:47
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 174

SEGUNDO INFORME

17-12 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 174.

La R. del S. 174, según referida, propone ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la existencia, accesibilidad, asequibilidad y suficiencia en Puerto Rico de: salas de parto y unidades materno-infantiles en cada distrito senatorial, en atención a la necesidad y realidad demográfica de cada comunidad; servicios perinatales, obstétricos y de maternidad; profesionales de la ginecología y obstetricia; y la viabilidad de revisar la legislación y reglamentación existente para permitir una participación mayor de las doulas y enfermeras parteras en los procesos de parto, y de expandir la cubierta de los planes de seguros de salud para incluyan esos servicios.

Esta Comisión reconoce la importancia de garantizar una cobertura integral, accesible y de calidad de los servicios de maternidad, particularmente en comunidades con necesidades especiales o con limitaciones geográficas. No obstante, tras examinar la información disponible sobre la estructura actual del sistema de salud maternal en Puerto

Q

Rico, esta Comisión entiende que resulta necesario considerar una serie de factores demográficos, operacionales y de política pública que enmarcan la situación de las salas de parto y de los servicios materno-infantiles en la Isla.

En primer lugar, la realidad demográfica de Puerto Rico evidencia un declive sostenido y significativo en la natalidad. La tasa de fertilidad se ha reducido de aproximadamente 2.1 hijos por mujer en el año 2000 a cerca de 0.9 hijos por mujer para el año 2021, lo que sitúa a Puerto Rico entre las jurisdicciones con menor natalidad a nivel mundial. Este patrón demográfico anticipa una reducción poblacional continua en las próximas décadas, con proyecciones de una población considerablemente menor hacia el año 2050.

En ese contexto de baja natalidad, distintos sectores del sistema de salud han señalado que la demanda de servicios de maternidad ha disminuido de forma sustancial, lo que ha provocado el cierre de múltiples salas de parto en hospitales alrededor de la Isla. Según expuesto por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, dichos cierres responden, en gran medida, a criterios de viabilidad operacional y a la necesidad de ajustar la oferta de servicios a la demanda real existente. Asimismo, el pediatra-neonatólogo y catedrático asociado del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Álvaro Santaella, ha indicado que el número actual de salas de parto en operación resulta, en términos generales, consistente con la demanda vigente de nacimientos.

En segundo lugar, el mantener de salas de parto, unidades neonatales y personal médico y de enfermería altamente especializado en todos los distritos senatoriales — incluyendo zonas rurales o de baja densidad poblacional — conlleva costos operacionales elevados para las instituciones hospitalarias. En un escenario de baja utilización, imponer o promover una infraestructura homogénea podría resultar en unidades subutilizadas, con el consecuente riesgo de cierres adicionales, presiones financieras para los hospitales o un uso ineficiente de los recursos públicos y privados destinados al sistema de salud.



Sobre este particular, algunas instituciones hospitalarias han optado por atender partos en salas de operaciones generales, en lugar de mantener salas de maternidad independientes, como una medida pragmática ante la reducción sostenida de nacimientos. Este planteamiento fue expresado públicamente por el Secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, durante el mes de enero de 2025, como parte de una discusión más amplia sobre la reorganización de servicios hospitalarios en función de la realidad demográfica y fiscal de nuestra Isla.

En cuanto a la participación de doulas y enfermeras-parteras, así como la posible cobertura de sus servicios por parte de los planes médicos, esta Comisión reconoce la relevancia del tema y la aportación que dichos profesionales pueden realizar dentro de un modelo integral de atención materna. No obstante, entiende que estos asuntos requieren un análisis técnico y regulatorio especializado, que considere los estándares de acreditación, la coordinación con los servicios médicos existentes, la seguridad de las pacientes y la sostenibilidad financiera del sistema, elementos que exceden el alcance de la investigación general propuesta por la Resolución del Senado 174.

A la luz de lo anterior, esta Comisión concluye que, si bien la medida responde a preocupaciones legítimas, la investigación propuesta no toma en consideración de manera suficiente la realidad demográfica, la capacidad instalada existente y los ajustes estructurales que ya se han producido dentro del sistema de salud materno-infantil, ni demuestra que una investigación adicional resulte necesaria o conducente en este momento para adelantar soluciones efectivas de política pública.

A la luz de lo anterior, esta Comisión considera que la medida, aunque motivada por preocupaciones legítimas, no refleja de forma integral los factores demográficos y estructurales que han redefinido la prestación de servicios materno-infantiles en Puerto Rico. Por ello, y considerando la información disponible y los ajustes ya realizados dentro del sistema de salud materno-infantil, esta Comisión concluye que no procede recomendar su aprobación en este momento.

9

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 174.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente